Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Maux de tête inhabituels

Tout public · non communicant : changement de comportement

15 IMMÉDIAT · mal de tête **brutal, « coup de tonnerre »** (maximal en moins d'une minute) ; avec fièvre et taches violacées (purpura), raideur de nuque, somnolence, confusion, convulsion ; avec paralysie, trouble de la parole ou de la vue ; après un choc sous **anticoagulant**.

J'applique si

- Mal de tête **nouveau, différent** de d'habitude ou qui s'aggrave.

Je ne fais pas

- Antalgique ou anti-inflammatoire sans validation de l'IDE.
- Faire manger ou boire une personne somnolente ou qui vomit.
- Laisser seule une personne qui a chuté et se plaint de la tête.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Au calme, pièce peu éclairée ; ne pas laisser seule ; vomit ou somnolente : sur le côté, **PLS**.
2. Plusieurs personnes ont mal à la tête : **monoxyde de carbone** ? → aérer, évacuer, **15**.
3. Début **brutal** ou progressif ? Heure ? Différent des maux de tête habituels ?
4. **TA**, pouls, **T°**, SpO2 ; **glycémie capillaire** (AS/AP) ; douleur EN ou Algoplus.
5. Chute ou choc récent ? **Anticoagulant, antiagrégant** ? Vomissements, nuque raide, vue, parole, équilibre ?

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

6. Paracétamol **seulement** selon « Paracétamol – Douleur et/ou fièvre », validé par l'IDE.
7. Protocole individuel (migraine, HTA) : l'IDE l'applique ou le valide.

ENSUITE

8. Signe d'AVC → « Suspicion d'AVC » ; après choc → « Traumatisme crânien ».

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toujours** un mal de tête inhabituel, même sans signe de gravité.
- PAS > 200 mmHg (aux 2 bras), fièvre, vomissements, EN > 5 ou Algoplus > 3 : **sans délai**.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Douleur (même échelle), conscience, comportement, vomissements, TA, T°.
- Persiste ou revient malgré le traitement : avis médical (IDE → médecin ou DOTR).
- Heure de début, constantes, gestes, avis donnés.

À retenir : Mal de tête brutal, avec fièvre, signe neurologique ou après un choc sous anticoagulant = 15. Pas d'antalgique sans validation de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFEMC/SFN, Moisset X et al., Recommandations pour la prise en charge d'une céphalée en urgence, Douleurs 2018;19:4-16 ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 13 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiche 13 (2023) ; ASSURE IDF, fiche 2 (2023) ; SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022).

Réf. DOTR-AS-CEPHAL | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature